

보건복지부 고시 제2024-186호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 따라 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 (보건복지부 고시 제2024-178호(2024. 8. 28.))을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2024년 9월 25일
보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

II. 약제 “[131] Netarsudil Mesylate 외용제 (품명: 로프레사점안액 0.02%), [232] Zastaprazan 경구제(품명: **자큐보정** 20밀리그램 등), [399] Evocalcet 경구제 (품명: 올케디아정 1,2밀리그램)”를 별지 1과 같이 신설하고, “[142] Mycophenolate mofetil 경구제(품명: 셀렘트캡슐 등), [229] Lung surfactant (폐계면활성제) 주사제(품명: 서팩텐 등), [439] Adalimumab 주사제(품명: 휴미라주 등), [439] Aflibercept 주사제(품명: 아일리아주사, 아일리아프리필드시린지 등), [439] Brolucizumab 주사제(품명: 비오뷰프리필드시린지), [439] Faricimab 주사제(품명: 바비스모주), [439] Ranibizumab 주사제(품명: 루센티스주 등, 루센티스프리필드시린지 등)”의 구분, 세부인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

부 칙

이 고시는 2024년 10월 1일부터 시행한다.

- 1 -

변경대비표

[별지 1]

[131] 안과용제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[131] Netarsudil Mesylate 외용제 (품명: 로프레사 점안액 0.02%)	<신 설>	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 개방각 녹내장, 고안압증을 진단받고, 기존 치료제 중 한 가지 이상에 적절하게 조절되지 않거나, 부작용 또는 금기로 사용할 수 없는 경우	○ Netarsudil Mesylate 외용제 (품명: 로프레사점안액 0.02%)가 신규 등재 예정임에 따라, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여 급여기준을 신설함.
※ 관련근거 · Williams Obstetrics, 26e (2022.) · MALIK Y. KAHOOK at el. Long-term Safety and Ocular Hypotensive Efficacy Evaluation of Netarsudil Ophthalmic Solution: Rho Kinase Elevated IOP Treatment Trial (ROCKET-2) Am J Ophthalmol 2019;200:130-137. · J. Bacharach at el. Double-masked, Randomized, DoseeResponse Study of AR-13324 versus Latanoprost in Patients with Elevated Intraocular			

Pressure, AAO Ophthalmology 2015;122:302-307

- Sanjay Asrani, et al. Fixed-Dose Combination of Netarsudil and Latanoprost in Ocular Hypertension and Open- Angle Glaucoma: Pooled Efficacy/Safety Analysis of Phase 3 MERCURY-1 and -2, Adv Ther, 2020, Apr;37(4):1620-1631.
- Clement Freiberg J, et al. Rho kinase inhibitor for primary open-angle glaucoma and ocular hypertension (Review), Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 6. Art. No.: CD013817. DOI: 10.1002/14651858.CD013817.pub2.
- 대한안과학회 (대한학 제14157호 (2023-256), 2023.10.4.)

[232] 소화성 궤양용제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[232] Zastaprazan 경구제 (품명: 자큐보정 20밀리그램 등)	<신 설>	각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - ○ 미란성 위식도역류질환의 치료	○ Zastaprazan 경구제 (품명: 자큐보정 20밀리그램 등)가 신규 등재 예정임에 따라, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여 급여기준을 신설함.
※ 관련근거 · Clinical Gastrointestinal Endoscopy, 3rd ed. (2019.) · Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14th Edition. (2022.)			

- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e. (2022.)
- 2020 Seoul Consensus on the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease.
- Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux disease 2021.
- Jung-Hwan Oh et al. Randomized, Double-blind, Active-controlled Phase 3 Study to Evaluate Efficacy and Safety of Zastaprazan compared to Esomeprazole in Erosive Esophagitis. (평가 당시 미발간 상태)
- 대한소화기기능성질환·운동학회(대기운 2024-05-24, 2024. 5. 24.)
- 대한소화기내시경학회(대소내: 제2024-297호, 2024.5.30.)
- 대한소화기학회(대소학 제2024-62, 2024.5.23.)

[399] 따로 분류되지 않는 대사성 의약품			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[399] Evocalcet 경구제 (품명: 올케디아정 1,2밀리그램)	<신 설>	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 이차성 부갑상선 기능항진증을 보이는 투석중인 만성신부전 환자로서 동 약제를 투여하기 전 혈청칼슘이 9.0mg/dL 이상이고 부갑상선호르몬(iPTH)이 300pg/mL 이상인 경우 - 다만, 동 약제 투여 중 부갑상선호르몬(iPTH)이 150pg/mL 이상인 경우 지속투여를 인정함.	○ Evocalcet 경구제 (품명: 올케디아정 1,2밀리그램)가 신규 등재 예정임에 따라, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회의견, 대체약제 등의 급여기준 변경 등을 참조하여 급여기준을 신설함.

--	--	--	--

※ 관련근거

- 1) Goodman & Gilman's : The Pharmacological Basis of Therapeutics,14e, 2022.
- 2) DiPiro's Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 12e, 2023.
- 3) Katzung's Basic & Clinical Pharmacology, 16e, 2023.
- 4) Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO), 2017.
- 5) Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) 2017, 2003.
- 6) Fukagawa M et al. Head-to-head comparison of the new calcimimetic agent evocalcet with cinacalcet in Japanese hemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism. Kidney International (2018)
- 7) Ni Z et al. Comparison of the Oral Calcimimetics Evocalcet and Cinacalcet in East Asian Patients on Hemodialysis with Secondary Hyperparathyroidism. Kidney International Reports (2023)
- 8) Tsuruya K et al. Efficacy and safety of evocalcet in Japanese peritoneal dialysis patients Clinical and Experimental Nephrology (2019)
- 9) 대한신장학회(대신학 제2024-024호, 2024.01.22.)
- 10) 대한투석혈관학회 (KSDA 2024-3호, 2024.01.19.)

[별지 2]

[142] 자격료법제(비특이성 면역억제제를 포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[142] Mycophenolate mofetil 경구제 (품명: 셀셉트캡슐 등)	1. 허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여 함을 원칙으로 함. 2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여한 경우에도 요양급여를 인정함. - 아 래 - 가. ~ 카. (생 략) 다. <u>시신경척수염 범주질환(Neuromyelitis optica spectrum disorder)으로 진단된 환자 중 Azathioprine에 부작용이 있거나 반응이 없는 경우</u> 파. <u>소아 및 청소년 (만2세~만18세) 항 MOG 항체 연관 질환 환자로서 스테로이드 치료 중 재발이 있는 경우</u> 1) <u>투여용량: 600~1200mg/m2/d (최대</u>	1. 허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여 함을 원칙으로 함. 2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여한 경우에도 요양급여를 인정함. - 아 래 - 가. ~ 카. (현행과 같음) 다. <u>시신경척수염 범주질환(Neuromyelitis optica spectrum disorder)으로 진단된 환자</u> 파. <u>만 2세 이상의 항 MOG 항체 연관 질환 환자로서 스테로이드 치료 중 재발이 있거나 부작용 등으로 투여할 수 없는 경우</u> 1) <u>투여용량</u>	○ 국내·외 허가사항, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회(전문가) 의견 등을 참조하여 시신경척수염 범주질환의 1차 약제 인정 및 항 MOG 항체 연관 질환 환자 투여대상을 성인 까지 급여 대상 확대 및 문구 보완함

[142] 자격료법제(비특이성 면역억제제를 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	2g/d)	가) 소아(만 2세~만 18세): 600-1200 mg/m ² /d (최대 2g/d) 나) 성인: 750mg-3g/day	
	2) (생 략) 하. (생 략)	2) (현행과 같음) 하. (현행과 같음)	
	3. ~ 4. (생 략)	3. ~ 4. (현행과 같음)	

※ 관련근거

- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e, 2022
- Clinical Neurology & Neuroanatomy: A Localization-Based Approach, 2e, 2022
- CURRENT Diagnosis & Treatment: Neurology, 3e, 2020
- Update on the diagnosis and treatment of neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) - revised recommendations of the Neuromyelitis Optica Study Group (NEMOS). Part II: Attack therapy and long term management, 2024
- Saudi consensus recommendations on the management of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders (NMOSD), 2022
- Latin American consensus recommendations for management and treatment of neuromyelitis optica spectrum disorders in clinical practice, 2020
- Diagnosis and management of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder (NMOSD) in Iran: A consensus guideline and recommendations, 2017
- Jonathan, Giovannelli, et al. A meta-analysis comparing first-line immunosuppressants in neuromyelitis optica. Annals of clinical and Translational Neurology, 2021, 8(10), 2025-2037.
- Christy, Magdalena, et al. Comparative Analysis of Treatment Outcomes in Patients with Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder Treated with Rituximab, Azathioprine, and Mycophenolate Mofetil: A Systematic Review and Meta-analysis. Innovations in clinical neuroscience, 2022, 19(4-6), 51-64.

[142] 자격료법제(비특이성 면역억제제를 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
· Wenjuan, Huang, et al. Effectiveness and tolerability of immunosuppressants and monoclonal antibodies in preventive treatment of neuromyelitis optica spectrum disorders: A systematic review and network meta-analysis. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 2019, 35, 246-252.			
· Tahara, Masayuki, et al. Compassionate open-label use of rituximab following a randomised clinical trial against neuromyelitis optica (RIN-2 study): B cell monitoring-based administration. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 2022, 60, 103730.			
· Tahara, Masayuki, et al. Safety and efficacy of rituximab in neuromyelitis optica spectrum disorders (RIN-1 study): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet neurology, 2020, 19(4), 298-306.			
· Mealy, Maureen A., et al. Comparison of Relapse and Treatment Failure Rates Among Patients With Neuromyelitis Optica Multicenter Study of Treatment Efficacy. JAMA Neurology, 2014, 71(3), 324-330.			
· Jeong, In Hye, et al. Comparative analysis of treatment outcomes in patients with neuromyelitis optica spectrum disorder using multifaceted endpoints. Multiple Sclerosis Journal, 2016, 22(3), 329-339.			
· CADTH(2021.2)			
· EAP(2022.7)			
· Firestein & Kelly's Textbook of Rheumatology. Eleventh Edition. Copyright © 2021			
· Bradley and Daroff's Neurology in Clinical Practice Eighth Edition © 2022			
· Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e Copyright © 2022			
· CURRENT Diagnosis & Treatment: Neurology, 3e Copyright © 2019			
· Bruijstens AL, et al. E.U. paediatric MOG consortium consensus: Part 5 - Treatment of paediatric myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-associated disorders. European Journal of Paediatric Neurology. 2020;29:41-53.			
· Hegen H, Reindl M. Recent developments in MOG-IgG associated neurological disorders. Ther Adv Neurol Disord. 2020;13:1756286420945135.			
· Wynford-Thomas R, Jacob A, Tomassini V. Neurological update: MOG antibody disease. J Neurol. 2019;266(5):1280-6.			
· Li Shengde, et al. Long-term efficacy of mycophenolate mofetil in myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-associated disorders. Neurology - Neuroimmunology Neuroinflammation, 2020;7(3): e705			

[142] 자격료법제(비특이성 면역억제제를 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
· Cobo-Calvo A, et al. Evaluation of treatment response in adults with relapsing MOG-Ab-associated disease. J Neuroinflammation. 2019;16(1):134. · Chen JJ, et al. Steroid-sparing maintenance immunotherapy for MOG-IgG associated disorder. Neurology. 2020;95(2):e111. · Ramanathan S, et al. Clinical course, therapeutic responses and outcomes in relapsing MOG antibody-associated demyelination. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018;89(2):127-37. · Qi-Lun Lai, et al. Efficacy and safety of immunosuppressive therapy in myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-associated disease. Ther Adv Neurol Disord. 2021;14:1 - 20			

[229] 기타의 호흡기관용약

현 행		개 정(안)		사유
구 분	세부인정기준 및 방법	구 분	세부인정기준 및 방법	
[229] Lung surfactant (폐계면활성제) 주사제 (품명: <u>서팩텐</u>)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준 으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담 토록 함. - 아 래 - ○ 신생아 호흡곤란 증후군: 다음의 조건이 모두 충족되는 경우	[229] Lung surfactant (폐계면활성제) 주사제 (품명: <u>서팩텐</u>)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준 으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - ○ 신생아 호흡곤란 증후군: 다음의 조건이 모두 충족되는 경우	○ 국내·외 허가사항, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회(전문 가) 의견 등을 참조 하여 폐계면활성제의 급여대상을 확대하고 품목 급여삭제에

[229] 기타의 호흡기관용약

현 행		개 정(안)		사유
구 분	세부인정기준 및 방법	구 분	세부인정기준 및 방법	
등)	- 다 음 - 1) 환자의 호흡곤란증상이 뚜렷하고, 2) 흉부방사선 소견 호흡곤란증후군(RDS)의 특정적 소견(양 폐에 미만성의 망상파립상 음영, 공기 기관지음영과 연무상이 출현 하는 경우)이 있으며, 3) 기계적 환기 요구도: 적절한 혈중산소분 압(50-80mmHg)을 유지시키기 위한 인 공호흡기의 흡입 산소농도가 <u>40%(FiO2>0.4)를 초과하는 경우</u> ※ 인공호흡기(침습적 방법 및 비침습적 방법 포함) 사용은 환자의 전반적인 상 태(체중, 폐기능 상태, 기타 신체 장기 들의 상태 등)를 고려하여 의학적 판단 하에 시행되어야 함. 2. (생 략)	<u>큐로서프주</u> 등)	- 다 음 - 1) ~ 2) (현행과 같음) 3) 기계적 환기 요구도: 적절한 혈중산소 분압(50-80mmHg)을 유지시키기 위한 인 공호흡기의 <u>흡입 산소농도가 30%(FiO2 ≥0.3)이상인 경우</u> ※ 인공호흡기(침습적 방법 및 비침습적 방법 포함) 사용은 환자의 전반적인 상 태(체중, 폐기능 상태, 기타 신체 장기들 의 상태 등)를 고려하여 의학적 판단 하에 시행되어야 함. 2. (현행과 같음)	따른 고시 제 목 현행화 함.

[229] 기타의 호흡기관용약				
현 행		개 정(안)		사유
구 분	세부인정기준 및 방법	구 분	세부인정기준 및 방법	
	3. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. - 아 래 - ○ 태변흡인 증후군: 다음의 조건이 모두 충족되는 경우 - 다 음 - 가. 환아의 호흡곤란증상이 뚜렷하고 나. 흉부방사선 소견: 태변흡인증후군(MAS)의 특징적 소견(양 폐의 과환기, 폐문 주위의 불규칙한 음영 증가, 횡격막의 수평화)이 있으며, 다. 기계적 환기 요구도: 적절한 혈중산소 분압(50-80mmHg)을 유지시키기 위한 인공호흡기의 흡입 산소농도가 <u>40%</u> ($FiO_2 > 0.4$)를 초과하는 경우 4. ~ 5. (생 략)		3. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. - 아 래 - ○ 태변흡인 증후군: 다음의 조건이 모두 충족되는 경우 - 다 음 - 가. 환아의 호흡곤란증상이 뚜렷하고 나. 흉부방사선 소견: 태변흡인증후군(MAS)의 특징적 소견(양 폐의 과환기, 폐문 주위의 불규칙한 음영 증가, 횡격막의 수평화)이 있으며, 다. 기계적 환기 요구도: 적절한 혈중산소 분압(50-80mmHg)을 유지시키기 위한 인공호흡기의 흡입 <u>산소농도가 30%</u> ($FiO_2 \geq 0.3$) 이상인 경우 4. ~ 5. (현행과 같음)	
※ 관련근거 · Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine, 64, 1159-1159(2020) · Illustrated Textbook of Paediatrics, 11, 170-197(2022) > 11. Neonatal medicine				

[229] 기타의 호흡기관용약				
현행		개정(안)		사유
구분	세부인정기준 및 방법	구분	세부인정기준 및 방법	
· Litman's Basics of Pediatric Anesthesia, 11, 66-72(2022) > 11. The premature infant · Nelson Textbook of Pediatrics, Chapter 122, 929-949.e1(2020) · Nunn and Lumb's Applied Respiratory Physiology, 12, 174-182.e2(2021) · Principles and Practice of Mechanical Ventilation, 3e > Chapter 23. Mechanical Ventilation in the Neonatal and Pediatric Setting · Williams Obstetrics, 26e > CHAPTER 33: Complications of the Term Newborn · Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine, 38, 608-608 · European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome: 2022 Update · Guidelines for surfactant replacement therapy in neonates(2021) · Surfactant replacement therapy for respiratory distress syndrome in preterm infants: United Kingdom national consensus(2019) · WHO_Neonatal Clinical practice guideline(2018-2021) · Early Care of Neonates at Risk of Respiratory Distress Syndrome(2018) · Clinical Practice Guideline. Surfactant Replacement Therapy(2013) · Surfactant Administration via Laryngeal Mask Airway (LMA) Standard Operating Procedure · Non - Delivery Room Management of Meconium Aspiration Syndrome(MAS)(2017) · Viraraghavan Vadakkencherry Ramaswamy et al., Surfactant therapy in late preterm and term neonates with respiratory distress syndrome: a systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2022 Jul;107(4):393-397. · Mohamed E Abdel-Latif et al., Surfactant therapy via thin catheter in preterm infants with or at risk of respiratory distress syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 5. Art. No.: CD011672. · Yong Yang et al., Lung recruitment improves the efficacy of intubation-surfactant-extubation treatment for respiratory distress syndrome in preterm neonates, a randomized controlled trial. BMC Pediatrics (2022) 22:14				

[229] 기타의 호흡기관용약				
현 행		개 정(안)		사유
구 분	세부인정기준 및 방법	구 분	세부인정기준 및 방법	
· Pierre Tourneux et al., Early factors associated with continuous positive airway pressure failure in moderate and late preterm infants. European Journal of pediatrics(2023) · Calum T. Roberts et al., Predictors and Outcomes of Early Intubation in Infants Born at 28-36 Weeks of Gestation Receiving Noninvasive Respiratory Support. J Pediatr 2020;216:109-16 · Piotr Kruczek et al., FiO2 Before Surfactant, but Not Time to Surfactant, Affects Outcomes in Infants With Respiratory Distress Syndrome. Front. Pediatr. 9:734696.(2021) · Amr I El Shahed et al., Surfactant for meconium aspiration syndrome in term and late preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD002054.				

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[439] Adalimumab 주사제(품명: 휴미라주 등)	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가~아. (생 략)	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가~아. (현행과 같음)	○ 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회(전문가) 의견 등을 참조하여, Hurley stage 2 이상이며 HS-PGA 중증 또는 IHS4 중증 화

- 13 -

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	자. 화농성 한선염 1) 투여대상 다음 가), 나), 다) 조건을 동시에 충족하는 경우 - 다 음 - 가) 화농성 한선염 최초 진단 후 1년 이상 경과한 18세 이상 성인으로, 나) 2개 이상의 각기 다른 부위에 병변이 있고, 농양과 염증성 결절 수의 합이 3개 이상이며, 다) 항생제로 3개월 이상 치료하였으나 치료효과가 미흡하거나 부작용 등으로 치료를 중단한 <u>중증(Hurley stage III) 환자</u> ※ Hurley Stage III: 전체적인 부위에 걸쳐 흩어지거나 거의 흩어진, 또는 다수의 서로 연결된 공동 및 농양 (Diffuse or near-diffuse involvement or multiple	자. 화농성 한선염 1) 투여대상 다음 가), 나), 다) 조건을 동시에 충족하는 경우 - 다 음 - 가) 화농성 한선염 최초 진단 후 1년 이상 경과한 18세 이상 성인으로, 나) 2개 이상의 각기 다른 부위에 병변이 있고, 농양과 염증성 결절 수의 합이 3개 이상이며, 다) 항생제로 3개월 이상 치료하였으나 치료효과가 미흡하거나 부작용 등으로 치료를 중단한 <u>중증(Hurley stage II 이상이며 HS-PGA 중증(4점 이상) 혹은 IHS4 중증(11점 이상) 환자</u> ※ I) Hurley Staging - 병변 양상에 따라 Hurley Stage I/II/III II) HS-PGA - 전체 피부 면적 중 농양, 배출 누공, 염증성/비염증성 결절의	농성 한선염 환자에 급여를 확대함

- 14 -

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	interconnected tracts and abscesses across the entire area	수를 바탕으로 0-5점까지 평가 Ⅲ) IHS4: (결절 수)*1 + (농양 수)*2 + (누공 수)*4 = 합산 점수 합산 점수에 따라 IHS4 중증도 평가	
	2) (생 략) 차. (생 략) 2.~7. (생 략)	2) (현행과 같음) 차. (현행과 같음) 2.~7. (현행과 같음)	
※ 관련근거 1. Fitzpatrick's Dermatology, 9e > Chapter 84: Hidradenitis Suppurativa 2. Andrews' Diseases of the Skin, 13e > chapter 13 acne 3. Ferri's Clinical Advisor 2024 > hidradenitis suppurativa 4. Comprehensive Guide to Hidradenitis Suppurativa 2022 > Chapter 13. Disease Evaluation and Outcome Measure 5. North American clinical management guidelines for hidradenitis suppurativa: A publication from the United States and Canadian Hidradenitis Suppurativa Foundations. 6. British Association of Dermatologists guidelines for the management of hidradenitis suppurativa (acne inversa) 7. European S1 guideline for the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa 8. 대한여드름주사학회 피부과 전문의를 위한 화농한선염 길라잡이(2023) 9. A. B. Kimball et al, Two Phase 3 Trials of Adalimumab for Hidradenitis Suppurativa N Engl J Med 2016;375:422-34. 10. C. C. Zouboulis et al, Long-term adalimumab efficacy in patients with moderate-to-severe hidradenitis suppurativa/acne inversa: 3-year results of a phase 3 open-label extension study J Am Acad Dermatol 2019;80:60-9 11. F. G. Bechara et al, Efficacy and Safety of Adalimumab in Conjunction With Surgery in Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa The SHARPS Randomized Clinical Trial JAMA Surg. 2021;156(11):1001-9. 12. A. B. Kimball et al, Adalimumab for the Treatment of Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa Ann Intern Med.			

- 15 -

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	2012;157:846-55.		
	13. A. B. Kimball et al, Secukinumab in moderate-to-severe hidradenitis suppurativa (SUNSHINE and SUNRISE): week 16 and week 52 results of two identical, multicentre, randomised, placebo-controlled, double-blind phase 3 trials Lancet 2023; 401: 747 - 61		
	14. N. D.K. Koerts et al, Assessment tools and phenotype classification for hidradenitis suppurativa Clinics in Dermatology 2023;41:601 - 10		
	15. Daoud et al, Overview and comparison of the clinical scores in hidradenitis suppurativa: A real-life clinical data Front. Med. 10:1145152.		
	16. NICE: Adalimumab for treating moderate to severe hidradenitis suppurativa (TA392)		
	17. PBAC: Adalimumab for the treatment of moderate to severe hidradenitis suppurativa		
	18. CADTH CANADIAN DRUG EXPERT COMMITTEE FINAL RECOMMENDATION ADALIMUMAB New Indication: Hidradenitis Suppurativa		

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[439] Aflibercept 주사제	<추 가>허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	○ '아일리아주8밀리그램'이 신규 등재 예정으로 교체투여 등 문구 정비

- 16 -

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
(품명: 아일리아주사, 아일리아프리필드시린지 등)	- 아 래 - 가. 신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성 1) ~ 2) (생 략) 3) 초기 3회 투여 후 치료 효과판정에 따른 투여 방법 가) 치료효과가 없는 경우 다른 항체 치료제* 중 1품목에 한해 교체투여 가능함 (투여소견서 첨부 및 투여간격 준수). 교체한 약제로 3회 투여 후에도 치료효과가 보이지 않으면 그 이후 투여는 약제불문 요양급여로 인정하지 않음. 나) 치료효과가 있는 경우(초기 3회 투여 혹은 교체 후 3회 투여 포함) 약제를 선택(교체 포함)하여 지속 투여할 수 있음. * 다른 항체 치료제: Brolucizumab,	- 아 래 - 가. 신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성 1) ~ 2) (현행과 같음) 3) 초기 3회 투여 후 치료 효과판정에 따른 투여 방법 가) 치료효과가 없는 경우 다른 항체 치료제(Anti-VEGF 제제) 중 1품목에 한해 교체투여 가능함 (투여소견서 첨부 및 투여간격 준수). 교체한 약제로 3회 투여 후에도 치료효과가 보이지 않으면 그 이후 투여는 약제불문 요양급여로 인정하지 않음. 나) 치료효과가 있는 경우(초기 3회 투여 혹은 교체 후 3회 투여 포함) 약제를 선택(교체 포함)하여 지속 투여할 수 있음. <삭 제>	

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	<u>Ranibizumab, Faricimab</u> 나. 당뇨병성 황반부종 1) ~ 2) (생 략) 3) 투여횟수: 환자당 총 14회 이내 <u>(Ranibizumab, Faricimab, Brolucizumab 주사제 투여 횟수 포함)</u> 다. ~ 라. (생 략)	나. 당뇨병성 황반부종 1) ~ 2) (현행과 같음) 3) 투여횟수: 환자당 총 14회 이내(<u>다른 항체 치료제(Anti-VEGF 제제) 투여 횟수 포함</u>) 다. ~ 라. (현행과 같음)	
[439] Brolucizumab 주사제(품명: 비오뷰프리필드시린지)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성 1) ~ 2) (생 략) 3) 초기 3회 투여 후 치료 효과판정에 따른	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성 1) ~ 2) (현행과 같음) 3) 초기 3회 투여 후 치료 효과판정에 따른	○ 「Aflibercept 주사제(품명: 아일리아주사, 아일리아프리필드시린지 등)」의 급여기준 변경 문구에 따라 동일하게 보완

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	투여 방법 가) 치료효과가 없는 경우 다른 항체 치료제* 중 1품목에 한해 교체투여 가능함 (투여소견서 첨부 및 투여간격 준수). 교체한 약제로 3회 투여 후에도 치료효과가 보이지 않으면 그 이후 투여는 약제불문 요양급여로 인정하지 않음. 나) 치료효과가 있는 경우(초기 3회 투여 혹은 교체 후 3회 투여 포함) 약제를 선택(교체 포함)하여 지속 투여할 수 있음. * 다른 항체 치료제: Aflibercept, Ranibizumab, Faricimab 나. 당뇨병성 황반부종 1) ~ 2) (생 략) 3) 투여횟수: 환자당 총 14회 이내 (Ranibizumab, Faricimab,	투여 방법 가) 치료효과가 없는 경우 다른 항체 치료제(Anti-VEGF 제제) 중 1품목에 한해 교체투여 가능함 (투여소견서 첨부 및 투여간격 준수). 교체한 약제로 3회 투여 후에도 치료효과가 보이지 않으면 그 이후 투여는 약제불문 요양급여로 인정하지 않음. 나) 치료효과가 있는 경우(초기 3회 투여 혹은 교체 후 3회 투여 포함) 약제를 선택(교체 포함)하여 지속 투여할 수 있음. <삭 제> 나. 당뇨병성 황반부종 1) ~ 2) (현행과 같음) 3) 투여횟수: 환자당 총 14회 이내(다른 항체 치료제(Anti-VEGF 제	

- 19 -

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	Aflibercept주사제 투여횟수 포함	제) 투여횟수 포함)	
[439] Faricimab 주사제 (품명: 바비스모주)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성 1) ~ 2) (생 략) 3) 초기 3회 투여 후 치료 효과판정에 따른 투여 방법 가) 치료효과가 없는 경우 다른 항체 치료제* 중 1품목에 한해 교체투여 가능함 (투여소견서 첨부 및 투여간격 준수). 교체한 약제로 3회 투여 후에도 치료효과가 보이지 않으면 그 이후 투여는 약제불문 요양급여로 인정하지	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성 1) ~ 2) (현행과 같음) 3) 초기 3회 투여 후 치료 효과판정에 따른 투여 방법 가) 치료효과가 없는 경우 다른 항체 치료제(Anti-VEGF 제제) 중 1품목에 한해 교체투여 가능함 (투여소견서 첨부 및 투여간격 준수). 교체한 약제로 3회 투여 후에도 치료효과가 보이지 않으면 그 이후 투여는 약제불문 요양	○ 「Aflibercept 주사제 (품명: 아일리아주사, 아일리아프리필드시린지 등)」의 급여기준 변경 문구에 따라 동일하게 보완

- 20 -

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	아니함. 나) 치료효과가 있는 경우(초기 3회 투여 혹은 교체 후 3회 투여 포함) 약제를 선택(교체 포함)하여 지속 투여할 수 있음. * 다른 항체 치료제: Afibercept, Ranibizumab, Brolucizumab 나. 당뇨병성 황반부종 1) ~ 2) (생 략) 3) 투여횟수: 환자당 총 14회 이내 (Afibercept, Ranibizumab, Brolucizumab 주사제 투여횟수 포함)	급여로 인정하지 아니함. 나) 치료효과가 있는 경우(초기 3회 투여 혹은 교체 후 3회 투여 포함) 약제를 선택(교체 포함)하여 지속 투여할 수 있음. <삭 제> 나. 당뇨병성 황반부종 1) ~ 2) (현행과 같음) 3) 투여횟수: 환자당 총 14회 이내(다른 항체 치료제(Anti-VEGF 제) 투여횟수 포함)	
[439] Ranibizumab 주사제 (품명:루센티스주)	각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	○ 「Afibercept 주사제 (품명: 아일리아주사, 아일리아프리필드시린지 등)」의 급여기준 변경 문구에 따라 동일하게

- 21 -

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
등, 루센티스프리필드시린지 등)	- 아 래 -	- 아 래 -	보완
	가. 신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성 1) ~ 2) (생 략) 3) 초기 3회 투여 후 치료 효과판정에 따른 투여 방법 가) 치료효과가 없는 경우 다른 항체 치료제* 중 1품목에 한해 교체투여 가능함 (투여소견서 첨부 및 투여간격 준수). 교체한 약제로 3회 투여 후에도 치료효과가 보이지 않으면 그 이후 투여는 약제불문 요양급여로 인정하지 아니함. 나) 치료효과가 있는 경우(초기 3회 투여 혹은 교체 후 3회 투여 포함) 약제를 선택(교체 포함)하여 지속 투여할 수 있음. * 다른 항체 치료제: Afibercept, Brolucizumab, Faricimab	가. 신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성 1) ~ 2) (현행과 같음) 3) 초기 3회 투여 후 치료 효과판정에 따른 투여 방법 가) 치료효과가 없는 경우 다른 항체 치료제(Anti-VEGF 제제) 중 1품목에 한해 교체투여 가능함 (투여소견서 첨부 및 투여간격 준수). 교체한 약제로 3회 투여 후에도 치료효과가 보이지 않으면 그 이후 투여는 약제불문 요양급여로 인정하지 아니함. 나) 치료효과가 있는 경우(초기 3회 투여 혹은 교체 후 3회 투여 포함) 약제를 선택(교체 포함)하여 지속 투여할 수 있음. <삭 제>	

- 22 -

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	나. 당뇨병성 황반부종 1) ~ 2) (생 략) 3) 투여횟수: 환자당 총 14회 이내 <u>(Aflibercept, Faricimab, Brolucizumab 주사제 투여 횟수 포함)</u>	나. 당뇨병성 황반부종 1) ~ 2) (현행과 같음) 3) 투여횟수: 환자당 총 14회 이내(<u>다른 항 체 치료제(Anti-VEGF 제)</u> 투여횟수 포함)	
	다. ~ 라. (생 략)	다. ~ 라. (현행과 같음)	
※ 관련근거 · 망막 I , Fifth Edition, 2021. · Ryan's Retina. seventh Edition, 2022. · Age-Related Macular Degeneration Preferred Practice Pattern®. Ophthalmology. 2020 Jan;127(1):P1-P65. · Diabetic Macular Oedema Guidelines: An Australian Perspective. J Ophthalmol. 2023; 2023: 6329819. · Retinopathy, Neuropathy, and Foot Care: Standards of Care in Diabetes—2024, Diabetes Care 2024;47(Suppl. 1):S231 - S243. · Lanzetta P at al. Intravitreal aflibercept 8 mg in neovascular age-related macular degeneration (PULSAR): 48-week results from a randomised, double-masked, non-inferiority, phase 3 trial. Lancet 2024; 403: 1141 - 52. · Brown DM at al. Intravitreal aflibercept 8 mg in diabetic macular oedema (PHOTON): 48-week results from a randomised, double-masked, non-inferiority, phase 2/3 trial. Lancet 2024; 403: 1153 - 63.			